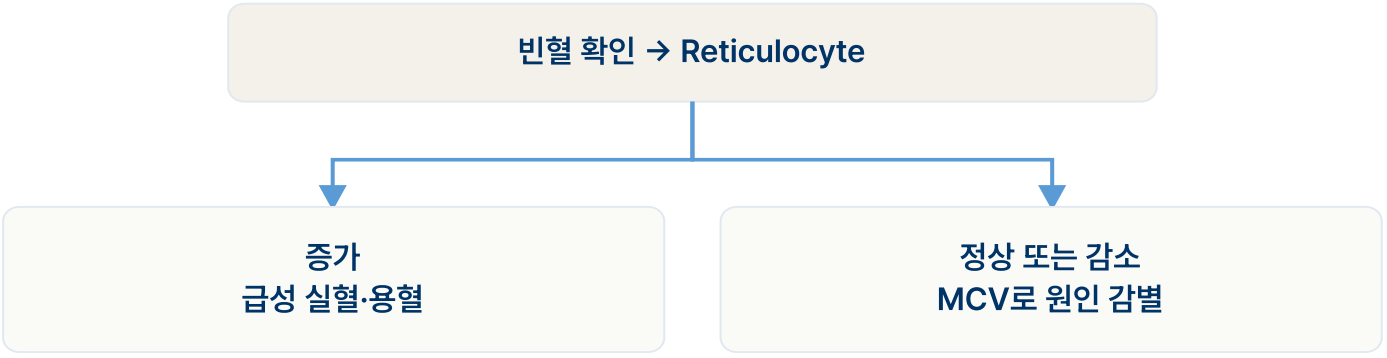
빈혈 초진
망상적혈구 → MCV

나이·다른 혈구·기저질환과 약물·이전 CBC를 함께 확인



빈혈의 정의 · 초진 병력

구분	진료 중 확인할 내용
혈색소(Hb)	남자 <13.0 g/dL · 여자 <12.0 g/dL · 임산부 <11.0 g/dL
네 가지 질문	나이·성별 / 빈혈 단독 또는 백혈구·혈소판 동반 이상 / 기저질환·약 / 급성 또는 만성
구체적으로 질문	CKD, 간질환, 위·장절제술, 최근 감염, 면역억제제·항생제·정신과 약, 음주

MCV별 다음 평가

구분	진료 중 확인할 내용
<80 fL · 소구성	국내에서는 대부분 철결핍빈혈(IDA). Iron/TIBC/ferritin 확인. 지중해빈혈·철적모구빈혈·일부 만성질환빈혈도 고려.
80~100 fL · 정구성	원인이 다양하므로 기저질환·약물과 다른 혈구 수치, 경과를 함께 해석.
>100 fL · 대구성	B12·folate 결핍, 음주·간질환, 골수질환(MDS), 약물, 용혈. MTX·hydroxyurea·azathioprine·valproate 확인.

Reticulocyte가 먼저인 이유

증가하면 급성 실혈·용혈에 대한 보상성 생성 증가를 생각합니다. 정상 또는 감소하면 재료 부족·골수 문제 등 생성 저하를 감별합니다.

빈혈의 원인 평가와 혈액내과 의뢰

소구성인데 철결핍이 아니거나, 대구성 원인이 뚜렷하지 않을 때

원인 평가의 갈림길

IDA 확인 · Iron↓, TIBC↑, ferritin↓, reticulocyte↓. 만성질환빈혈(ACD)이 동반되면 ferritin이 100~200의 정상 범위일 수 있음.

출혈원 평가 · 월경과다: 산부인과 진료. 남성·월경하지 않는 중년 이상 여성: 위·대장내시경으로 GI bleeding 평가. 치질 출혈·사혈·부항·잦은 헌혈도 질문.

철결핍이 아닌 소구성 · 어릴 때부터 빈혈·가족력·국적 등을 질문. Thalassemia 등 드문 원인 감별을 위해 혈액내과 의뢰.

대구성 검사 · CBC(PBS), reticulocyte, serum B12/folate, LDH·haptoglobin. 위전절제 후 8~10년 이상 지나 B12 결핍이 나타날 수 있고 범혈구감소로도 발현. RBC folate의 추가 진단 유용성은 제한적이라고 설명.

혈액내과 의뢰 · 본강

PBS의 blast·immature cell(백적혈모구성 반응 포함), 빠른 Hb 저하, 백혈구·혈소판 이상 동반, 원인이 불분명한 빈혈(특히 고령·대구성)이면 의뢰합니다. 용혈·약물·B12/folate 결핍을 설명할 수 없는 고령 대구성 빈혈은 골수질환을 감별합니다.

최은지 연자 Q&A · 추적과 추가 의뢰

기본검사·PBS·신기능 등을 검토한 경미한 빈혈이 장기간 비슷하면 연 1~2회 추적을 권유했습니다. 수년에 걸쳐서라도 Hb가 감소하면 혈액내과 평가를 권유했습니다. 새로 발생·진행하는 빈혈도 추가 평가 대상입니다.

최은지 연자 Q&A · 반복 IDA

처음 발견된 IDA는 위·대장내시경과 산부인과 등 원인 평가를 권유했습니다. 원인 불명 IDA가 반복되면 상급병원에서 잠재 GI 출혈 평가를 고려합니다. 내시경이 정상이면 필요에 따라 캡슐내시경, H. pylori, UA(혈뇨), APCT 등을 고려한다고 답했습니다.

! TMA 의심은 응급 의뢰

Schistocyte·혈소판감소에 신기능 저하 또는 신경학적 증상·혈전증이 동반되면 혈전성 미세혈관병증(TMA)을 생각하고 응급으로 혈액내과에 의뢰합니다.

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/clinical/asl28-117-anemia-referral/